

Alteraciones neuropsicológicas de los ACV isquémicos

Los síndromes clínicos que se originan tras un ACV isquémico presentan un patrón lo suficientemente uniforme para poder organizar la información en función de las arterias afectadas (Junqué y Barroso, 2007; Balmaseda et al., 2002).

Arteria cerebral anterior

- Cambios de personalidad y humor:
 - Aumento de la agresividad, irritabilidad, pérdida de las normas de comportamiento social (en lesiones del córtex prefrontal orbital).
 - Abulia, lentitud, falta de espontaneidad y en casos extremos mutismo acinético (en lesiones de las vías frontales con el núcleo caudado).
 - Trastornos obsesivo-compulsivos (en lesiones paralímbicas y orbitales).
- Trastorno atencional: Dificultades para fijar la atención e inhibir estímulos. La lesión afecta a las conexiones con el sistema reticular ascendente y al lóbulo frontal.
- Heminegligencia: Falta de atención a una parte del campo visual contralateral a la lesión.
- Disfunción ejecutiva: Dificultades en la planificación, secuenciación, monitorización y verificación de los resultados de una tarea. La lesión se localiza en los lóbulos frontales.
- Afasia motora transcortical: Lenguaje espontáneo reducido y buena denominación, comprensión y repetición. Escritura alterada, pero la lectura mecánica y la comprensión lectora están preservadas. La lesión suele localizarse en la región parasagital superior o área motora suplementaria del hemisferio dominante.
- Síndrome de utilización: Consiste en la tendencia del paciente a usar los objetos que están a su alcance sin que se le hayan dado instrucciones de hacerlo y sin una finalidad lógica.
- Síndrome de desconexión callosa: Aparecen una apraxia de los miembros superiores (incapacidad para realizar gestos simbólicos por orden o imitación con la mano izquierda) y agrafia. Se producen porque la mano izquierda, que es controlada por el hemisferio derecho, carece de información lingüística y práxica, procesada por el hemisferio izquierdo.

Arteria coroidea anterior

- Afasia: Por alteración del hemisferio dominante.
- Amnesia: Por afectación del hipocampo.
- Trastornos emocionales: Si se afecta la amígdala.

Arteria cerebral media

- Anosognosia.
- HemiinatenCIÓN.
- Heminegligencia contralateral.

Arteria cerebral media izquierda

- Afasia de Broca: Afasia de tipo no fluido, con pobre repetición y comprensión relativamente preservada. Suele acompañarse de apraxia orofacial, agrafia y alexia frontal. La lesión se localiza en el área 44 de Broadman.
- Afasia de Wernicke: Se caracteriza por un lenguaje fluido, parafásico, con pobre repetición y déficit en la comprensión. La lesión se localiza en el área 22 de Broadman.

- Afasia de conducción: Trastorno en la repetición, lenguaje espontáneo fluido y parafásico, preservada la comprensión auditiva. Están lesionadas las conexiones que transmiten la información del sistema auditivo al sistema motor.
- Afasia nominal: Dificultad para decir el nombre de las cosas, con buena comprensión.
- Síndrome de Gerstmann: Se caracteriza por agnosia digital, agraphia pura, desorientación derecha-izquierda y acalculia. Está producido por lesiones del lóbulo parietal izquierdo.
- Alexia central o alexia con agraphia: Alteración de la lectura y escritura siendo el lenguaje oral normal.
- Apraxia ideomotriz: Dificultad para realizar gestos simbólicos, tanto por orden verbal como por imitación.
- Trastornos de la memoria. Por afectación del lóbulo temporal izquierdo, del hipocampo y de la amígdala.

Arteria cerebral media derecha

- Heminegligencia izquierda: Incapacidad para orientar o identificar un estímulo que aparece en uno de los hemiespacios o incapacidad para mover espontáneamente los miembros hacia un lado en ausencia de trastornos sensoriales o motores.
- En fase aguda, puede aparecer un síndrome confusional. Se muestran apáticos, con falta de respuesta emocional e incapacidad para interpretar correctamente las emociones de los demás.
- Alexia, agraphia y acalculia espaciales: Errores en el cálculo de números y en el uso del espacio en la lectura y en la escritura.
- Apraxia del vestir y apraxia constructiva.
- Alteraciones visoespaciales y visoperceptivas: Dificultades para percibir figuras superpuestas, identificar las caras de personas nuevas y orientar correctamente líneas, figuras u objetos en el espacio.

Cerebral posterior izquierda

- Afasia sensorial transcortical: Lenguaje fluido, comprensión muy alterada y repetición preservada. Frecuentemente aparece jerga en el lenguaje espontáneo que no está relacionada con la conversación. La lesión se localiza en zonas temporooccipitales.
- Afasia o anomia ópticas: Trastorno selectivo de denominación ante estímulos visuales. Están preservadas la evocación de nombres en el lenguaje espontáneo y la denominación a partir de identificación táctil de objetos.
- Alexia pura: Incapacidad para leer estando preservadas la escritura espontánea y el dictado. La copia también está alterada. La lesión se localiza en las fibras que unen el córtex visual con el córtex lingüístico temporoparietal).
- Anomia cromática: Incapacidad para decir el nombre de los colores o de señalar el color correspondiente al nombre que el examinador presenta. Se produce por la desconexión de zonas occipitales y las de lenguaje.
- Alteraciones de la memoria verbal: En fases iniciales pueden aparecer amnesias globales que posteriormente se reducen a alteraciones en la capacidad para memorizar material verbal.

Arteria cerebral posterior derecha

- Apraxia constructiva: Alterada la copia.
- Alteraciones visoespaciales y visoperceptivas: Similares a las alteraciones de la arteria cerebral media. Además, suele estar afectada la capacidad para imaginar espacios.

Arteria cerebral posterior: afectación bilateral

- Agnosia visual: Incapacidad para reconocer objetos presentados visualmente, sin que existan alteraciones lingüísticas ni visuales evidentes. Un tipo especial de agnosia visual es la prosopagnosia, o capacidad para reconocer caras de personas conocidas.
- Ceguera cortical.
- Acromatopsia: Trastorno que altera la percepción del color. La lesión se localiza en el esplenio del cuerpo calloso.
- Anosognosia visual: No reconocimiento de la ceguera de un paciente ciego.

Tabla 6. *Principales déficits neuropsicológicos de los ACV isquémicos en función de la arteria cerebral afectada. Modificado a partir de Junqué y Barroso (2007), y Balmaseda et al. (2002).*

Alteraciones neuropsicológicas de los ACV hemorrágicos

En las hemorragias se producen fundamentalmente cuatro tipos de **efectos a nivel cerebral**:

- ***Destrucción localizada de tejido***: La interrupción de los circuitos córtico-corticales y córtico-subcorticales producen déficits de desconexión.
- ***Compresión de estructuras cerebrales por el hematoma***, que puede ser compresión intrahemisférica (del tejido circundante) o compresión contrahemisférica (del hemisferio contralateral). Observándose desplazamiento de la línea media, o compresión del sistema ventricular, con el uso de pruebas diagnósticas de imagen.

En las fases agudas es frecuente que aparezcan alteraciones neuropsicológicas que en principio no son las esperadas por la lesión local. Dichas alteraciones se deben sobre todo a la compresión intrahemisférica y contrahemisférica.

Si el paciente sobrevive a la hemorragia suele producirse una rápida mejoría de las alteraciones cognitivas en los dos primeros meses.

- ***El daño difuso relacionado con el estado de coma***. Cuando se ha producido un estado de coma prolongado es frecuente que aparezcan alteraciones en la atención, la memoria y cambios de carácter, unidas a las alteraciones propias del daño focal. Seguramente estos déficits se deben a la compresión sanguínea sobre el sistema límbico.
- ***El tratamiento quirúrgico***. Determinadas intervenciones quirúrgicas conllevan el riesgo de provocar lesiones añadidas al ACV hemorrágico. Por ejemplo, en la extirpación de malformaciones arteriovenosas o en la evacuación de hematomas.

Según Santiago (2009), las principales alteraciones que conllevan las **hemorragias subaracnoideas** serían:

- Problemas de memoria, sobre todo verbal, tanto a corto como a largo plazo.
- Atención.
- Concentración.

- Flexibilidad mental.
- Lenguaje.
- Procesamiento de la información.
- Velocidad cognitiva.

Según esta misma autora, las **hemorragias por rotura de aneurisma de la arteria comunicante anterior** suelen conllevar los siguientes déficits:

- Problemas de memoria: Alteración de la memoria retrógrada.
- Confabulación, unida o no a disfunción ejecutiva (disminución de flexibilidad, problemas en la formación de conceptos, alteraciones en la planificación).
- Cambio de personalidad, en dos sentidos: apáticos/desmotivados o desinhibidos/agresivos.

Según Junqué y Barroso (2007), las **hemorragias por rotura de los aneurismas de la arteria comunicante posterior** suelen conllevar alteraciones similares a las de la arteria cerebral media:

- Síndrome de negligencia: atencional, motora y espaciales.
- Apraxia constructiva.
- Apraxia del vestir.